EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 89360
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-07-26 09:21:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: CRISTINA PAOLA MOLINA SAN MARTIN			RUN	: 15.809.528-9
F.Nac	: 23-04-1984	Edad	: 40 AÑOS, 3 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: Las Arboledas			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: 94969332		
Fecha Ingreso	: 2024-07-11	Fecha Egreso	: 2024-07-26 09:21:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. L03.1-CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIENBROS

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1) Celulitis EII en tratamiento
2) Ulcera varicosa maleolo medial izq sobreinfectada

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. L03.1-CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIENBROS (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antec de ulcera varicosa en región maleolar medial desde hace 3 años en curaciones, consulta en SU HSC el 10/07 por cuadro de 3 dias de evolución de CEG; algia, eritema y AVO de EII, nauseas, vomitos, fiebre objetivada hasta 40°C. Refiere consulta en primera instancia en APS el mismo dia , donde se inicia terapia ATB con amoxicilina/Ac Clavulanico.
Examenes de lab al ingreso -> Glicemia 109; crea 0,9; ac urico 4,9; PCR 315; BUN 17; uremia 37; Gb 38,1; Hb/Hcto 13.4/39.9; plaq 280000; segment 94%; VHS 60; INR 1,56, dimero D 1223.6
Examen físico al ingreso no registrado
Evaluado por cirugía, quien descarta eventual aseo quirúrgico para desfocar foco infeccioso
En vista de condiciones clínicas, se decide ingreso para terapia ATB y manejo de patologia
Eco doppler venoso EII 11/07 -> No se aprecian imágenes endoluminales sugerentes de trombos, examen negativo para TVP, edema del tejido subcutáneo difuso distal, sin colecciones

Ex físico -> Vigil, CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Extremidades se aprecia eritema, AVO e induración de tercio distal de EII, en mayor cuantia hacia medial, con extensión hacia tercio medio. Aposito de ulcera varicosa se aprecia con secreción seropurulenta???, con mayor eritema pericircundante a ulcera. Sin colecciones subcutáneas al tacto. Pulsos pedios y tibiales posteriores conservados, sin perdida de sensibilidad ni frialdad hacia distal
Se decide ingreso para terapía ATB
Durante estadia con parametros inflamatorios en ascenso, con mayor edema de EII
Cultivo de herida con desarrollor de acinetobacter baumaniisensible a ampicilina/sulfactam; serratia marcescens resistente a ampicilia/sulfactam, sensible a ceftriaxona, S pyogens multisensible
TAC de extremidades -> Edema del tejido celular subcutaneo, de la pierna izquierda y engrosamiento del plano dermico epidermico, sobre todo en cara medial del tobillo izquierdo, con lesion de aspecto ulcerativa.
Se adiciona terapia ATB con ceftriaxona, de forma posterior con descenso de parametros inflamatorios
Paciente HDN estable, afebril, con menos molestias en extremidad inferior afectada, sin episodios de nauseas y/o vomitos, con buena tolerancia a alimentacion VO, diuresis y deposiciones (+)
Examenes de lab -> crea 0,6; lactato 0,8; PCR 22,1; uremia 21; Gb 3,4; Hb/Hcto 11.9/34.4; plaq 407000; segment 48%; GSV pH 7,37
Ex fisico -> Vigil, CLOTE; mucosas rosadas, hidratadas, llene capilar < 2 segs
Cardiaco RR2T NAS
Pulmonar MP (+) SRA
Extremidades con eritema en tercio inferior de EII, lesiones mediales de aspecto necrotico

Paciente en su dia N° 15 hospitalizado, dia N° 12 ceftriaxona, terapia ATB con ampicilina sulfactam en dia N° 14 ya cumplido, en condiciones de continuar hospializacion via HODOm

PLAN DE MANEJO:

1) HDN: Estable, sin conflicto
2) Ventilatorio: Estable, snn conflicto
3) Infeccioso/Cutaneo: Con parametros inflamatorios en descenso, se completan 14 dias de terapia ATB con ampicilina/Sulfactam, en condiciones de continuar hospitalizacion via HODOm
4) Quirurgico: Evaluado por cirugia, quienes sugieren curaciones con clorexidina jabonosa y seguimiento posterior

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo semisentada 30°
2. Regimen liviano a tolerancia
3. Metoclopramida 10 mg c/12 hrs VO por 5 dias
4. Paracetamol 500 mg, 2 comp c/8hrs VO SOS por 5 dias
5. Curaciones avanzadas de ulcera dia por medio con clorhexidina jabonosa
6. CSV c/8hrs
7. Pregabalina 75 mg, medio comp c/12 hrs VO por 5 dias
8. Metamizol 300 mg c/8hrs VO por 5 dias
9. Ceftriaxona 2 gr al dia EV por 2 dias
10. Examenes de control 29/07

DANIEL EDUARDO ACEVEDO PEREIRA
MEDICO TRATANTE
18431829-6

JEFE SERVICIO